جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : جملات حبشى ابراهيم موسى
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الاخصاص **العنوان :** --
رقم البطاقة : 26607252600167 **رقم التليفون :** 01147675061 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 10-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 25-07-1966 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: جملات حبشى ابراهيم موسى
National ID: 26607252600167

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

٤٣٤٦

Patient Name: Gamalat Habashi Ibrahim Mousa	Date : 18/11/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 59 Year(s)
Medical ID: 545/2024	Pat. ID: 94479

BILATERAL BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after left conservative surgery.

Right Breast:

- Homogenous fatty background of breast parenchyma.
- **No detected suspicious masses.**
- No detected significant axillary Lns.

Left Breast:

- Homogenous fatty background of breast parenchyma.
- **Thickened left breast skin with underlying edema .**
- **Infected seroma was seen in the left breast underneath the operative bed on 12 oclock , measuring 6 x 3 cm .**
- **Otherwise; clear operative bed with no evidence of residual or recurrence.**
- **No definite suspicious masses.**
- No detected significant axillary LNs.

CONCLUSION:

- ***Normal right breast (BIRADS 1 category)..***
- ***Post conservative changes of the left breast (BIRADS 2 category).***

Dr farah elshobaky

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]

Name: جملات حبشي ابراهيم **MR. :** 4346	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is receiving letrozole (Femara) together with a supportive supplement regimen, which has been continued for three months with a planned pause on 10 March 2026. Imaging identified a 2 × 1.3 cm lesion consistent with a likely hemangioma, and the patient will be followed up for this finding.

The patient has a diagnosis of breast cancer and has been on hormonal therapy with an aromatase inhibitor (Femara) since June 2024; the current plan is to continue Femara for an additional three-month course.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **Ali Adel**

يعتمد ,

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Gamalat Habashi Ibrahim Mousa	Date : 20/10/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 59 Year(s)
Medical ID: 545/2024	Pat. ID: 94479

MULTI-SLICE NON-CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST WITH RECONSTRUCTION IMAGES REVEALED:

FINDINGS:

- Post operative status for a known case of left breast cancer showed diffuse skin thickening with underlying encysted collection measuring 61 x 42 mm likely post operative seroma.
- No pulmonary consolidation or collapse.
- No evidence of pulmonary nodules, masses or cavitation.
- No sizeable hilar or mediastinal lymphadenopathy.
- No evidence of pleural or pericardial effusion.
- No gross cardiac abnormality.
- Normal appearance of the chest wall.

OPINION:

- ***Post operative status for a known case of left breast cancer showed diffuse skin thickening with underlying encysted collection measuring 61 x 42 mm likely post operative seroma.***

Dr. Asser Ahmed

Dr. Asser Ahmed

Signature Dr.Mohamed Hassan
23/10/2025 12:42 AM

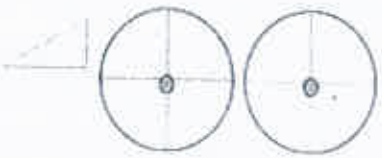
CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : جمالات حبشى ابراهيم موسى
Sex: Female
3- Medical number: 83188122
Old Med : 545-2024
2-ID number: 26607252600167
Patient Age : 58 Y



Family history	Family History +ve	Phone	Phone 01152248798	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT NEW
marital status	Marital Status	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date Of MDT 26/05/2024
Co morbidity	Co Morbidity	Menopausal status	Menopausal Status POSTMENOPAUSAL	Initial STAGE	Initial STAGE		

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
BX COMMENT	7/8 ER COMMENT	5/8 PR COMMENT	0 Her 2 Neu COMMENT	SISH COMMENT	

T	N	M

Sonomammography

PATIENT HISTORY

lt breast mass wide local excision LN disease
IDC LN 1/11 T2 N1 M0
received RTH post operative
bone scan:free

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

patient lost the window for chemotherapy ,
For Adj. AI.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/هدان عزت د/ يحيى اسماعيل	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ امل مختار
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Cairo University
National Cancer Institute
Department of Diagnostic and
Interventional Radiology

جامعة القاهرة
المعهد القومي للأورام
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

Exam Information:

Patient Name: *Gamlat Habashy*	***Date of birth:*** *25/07/1966*
Arabic Name: جملات حبشى	***Patient Gender:*** *F*
Patient RIS ID: *354050* ***Patient HIS ID:*** *124008124*	***Exam Date:*** *01/05/2024*
Written by: Dr. Hoda Fathy	**Approved by:** Dr. Hoda Fathy

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (1/5/2024)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP

Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obliged

Mahmoud Akram

Omnia Talaat, MD

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Gamalat Habashi Ibrahim Mousa	Date : 21/11/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 58 Year(s)
Medical ID: 545/2024	Pat. ID: 94479

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had left CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast UIQ rather central focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring partially obscured equal density mass, and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed left breast 12o'clcok focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with seroma, measured 3x7cm, no evidence of recurrent mass lesions.
- no right breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

21/11/2024 5:08 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name	: الأستاذه / جملات حبشى ابراهيم موسى	Request No.	: 13009040
Patient No.	: 26607252600167	Request Date	: 22/02/2024
Path No.	: SR-269/24	Verification Date	: 05/03/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 57 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Slide revision.

Gross Examination:
- Three blocks labelled by (3401) were received.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* *Ductal carcinoma in situ*: Focal DCIS (non comedo <5%).
* Perineural invasion: No.
* Angioinvasion: No.
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Moderate nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 7/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 15% of tumor cells (score 5/8).
- Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
- Ki67: 15% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Left breast mass, slide revision:
Invasive duct carcinoma, Grade II with focal DCIS (non comedo <5%).
IPT:
- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Positive (score 5/8)
- Her2: Negative (score 0).

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الاول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

The General Organization for Teaching Hospital and institutes
Ahmed Maher Teaching Hospital

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
مستشفى أحمد ماهر التعليمى

قسم الباثولوجي

إسم المريض : حمالات حبشى ابراهيم | السن : 54 سنه

محول من : د/ مصطفى بدر (2023 - 3401) (2023 - 57108)

تاريخ الحضور : 2023/11/07 | تاريخ الإستلام : 2023/11/25

NATURE OF SPECIMEN :

Left breast mass wide local excision with axillary lymph node excision.

GROSS :

Three specimens were received
1) Wide local excision specimen measured 14x8x3cm with skin ellipse measured 8.5x3cm. Serialling revealed an ill defined firm grey white mass measured 2.2x1.5x1cm grossly reaching inferior margin and located (4cm, 4.9cm, 2cm, 10cm and 2cm) medial, lateral, superior, deep and skin respectively.
2) Extra inferior margin:A fibrofatty tissue piece measured 6x4x2cm.
3) Fibrofatty tissue piece measured 5x3cm revealed 11lymph nodes, the largest one measured 1.8x0.5cm.

MICROSCOPY :

Sections examined revealed invasive duct carcinoma (NST). The tumor forms clusters, tubules of moderate anaplastic cells with moderate tendency to form tubules with occasional mitosis among desmoplastic stroma showing areas of calcifications. All surgical margins, extra inferior margin and skin were free of tumor. Serialling of axillary lymph nodes revealed one positive node (1/11).

DIAGNOSIS :

- Left breast mass wide local excision with axillary lymph node excision; INVASIVE DUCT CARCINOMA (NST), ALL SURGICAL MARGINS, EXTRA INFERIOR MARGIN AND SKIN WERE FREE. LYMPH NODES STATUS (1/11) (T2 N1 R0).

RECOMENDATION :

دأضى محمد

دارشا فاروق

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]